Poder Judiciário de Mato Grosso do Sul
Comarca de Campo Grande
4ª Vara Cível Residual

Processo: 0826839-89.2018.8.12.0001
Autos: Procedimento Comum Cível
Autor: Cleida Maria Lauria Lima, Daniela Lauria Lima, Roberta Lauria Lima e Ronaldo Lanes Lima
Réu: Unimed Nova Friburgo Sociedade Cooperativa Médica Ltda

Vistos, etc.

Trata-se de *Ação de Indenização por Danos Materiais* que **Ronaldo Lanes Lima e Cleida Maria Lauria Lima** movem em face de **Unimed Nova Friburgo Sociedade Cooperativa Médica Ltda**, todos devidamente qualificados nos autos.

Narra a inicial que, os autores eram beneficiários da cooperativa Unimed Teresópolis até a aquisição da carteira de beneficiários pela ré Unimed Nova Friburgo e atualmente fazem uso do plano de modalidade individual, NA07 especial, e que para usufruir dos serviços médico hospitalares contratados, pagam boletos mensais à título de contraprestação e encontram-se adimplentes.

Aduzem que são pessoas idosas, e são acometidos por diversas patologias, sendo que o autor Ronaldo tem o diagnóstico de esponcilite anquilosante e a autora Cleida de tumor cerebral à esquerda e por esta razão ambos se submetem a tratamento médico.

Declaram que a autora Cleide teve um mal súbito em meados de fevereiro de 2018, a após comparecer ao pronto socorro em seu município para realizar exames, foi diagnosticada com quadro de cefaleia. Em razão disso, esclarece que o médico que lhe assistia recomendou realizar consulta com médico neurocirurgião no município de São Paulo/SP, tendo em vista a complexidade do caso, e que ao se consultar com o Dr. Félix Hendrik Pahl foram localizadas lesões expansivas no crânio consequentes do diagnóstico de gliobastoma Multiforme.

Que em razão da gravidade do tumor, foi prescrito à autora submissão à microcirurgia para ressecamento do tumor, o qual fora realizado no Hospital Sírio Libanês na data de 06/03/2018, e em sequência a autora foi submetida a sessões de radioterapia associada com quimioterapia com uso do medicamento Temodal, sendo a radioterapia dividida em 30 (trinta) frações, que duraram 06 (seis) semanas, e mesmo tendo encerrado o tratamento de radioterapia, a autora ainda não recebeu alta definitiva, vez que é submetida a tratamento paliativo com o intuito de controlar o crescimento do tumor.

Alegam que as despesas junto ao Hospital Sírio Libanês foram no montante de R$ 204.642,63 (duzentos e quatro mil, seiscentos e quarenta e dois reais e sessenta e três centavos), e que mesmo que tal hospital não seja credenciado junto à ré, alegam que o contrato pactuado entre as partes autoriza que o beneficiário solicite o reembolso das despesas auferidas de forma particular para serem pagas de acordo com a tabela de reembolso e no valor correspondente ao pago pelos profissionais credenciados.

Porém, ao solicitar o reembolso junto a ré, a mesma negou a solicitação, justificando inexistir obrigação contratual, e que mesmo em relação ao medicamento Temodal, também foi negado o reembolso sob a justificativa de inexistência de cobertura contratual.

Quanto ao autor Ronaldo, aduzem que o mesmo possui diagnóstico de esponcilite anquilosante desde os 18 (dezoito) anos de idade, e que em 2007 foi submetido a cirurgia de prótese de quadril junto ao Hospital Sírio Libanês, e que no ano de 2014 precisou

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por VANIA DE PAULA ARANTES, liberado nos autos em 17/12/2021 às 09:30 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0826839-89.2018.8.12.0001 e código UmgcPw7j.

ser novamente internado no referido hospital e lá foi submetido a artrodose de T12 a L5, e que as despesas com a internação totalizaram o montante de R$ 194.863,14 (cento e noventa e quatro mil, oitocentos e sessenta e três reais e quatorze centavos), sendo que o autor pleiteou o reembolso junto a ré, porém, também foi informado de que as despesas não eram cobertas pelo contrato e por isso não haveria possibilidade de reembolso.

Requerem, assim:

- condenação da ré ao reembolso das despesas médico-hospitalares despendidas junto ao Hospital Sírio Libanês, nos limites que pagaria no melhor hospital da rede credenciada à categoria da autora, bem como a cobertura pelo medicamento Temodal (utilizado pela autora Cleida) e o pagamento das despesas com as próteses implantadas pelo autor Ronaldo, que devem ser reembolsadas de forma integral.

Despacho de fl. 167/168, onde designou-se audiência de conciliação e determinou-se a citação da ré.

Contestação às fls. 173/196, onde a Unimed Teresópolis Cooperativa de Trabalho Médico aduz que os autores são beneficiários do plano de saúde médico hospitalar firmado com a ré, desde 11/10/1996, sendo este anterior à Lei 9.656/98, que regulamenta os planos de saúde, e que quando do advento da referida legislação, os beneficiários do plano de saúde poderiam optar pela regulamentação do seu contrato com a lei ou continuar com a manutenção do contrato antigo (anterior à Lei 9.656/98). Diz que os beneficiários que optariam pela regulamentação, pagariam um valor a maior a título de mensalidade, porém teriam os benefícios trazidos pela Lei 9.656/98, e os que optaram pela não regulamentação, continuariam pagando o mesmo valor de mensalidade e não teriam as vantagens oferecidas pela nova legislação, e que os autores tiveram a opção de adaptar seu contrato (art. 35 da Lei 9.656/98), porém resolveram permanecer com o contrato anterior, não regulamentado pela Lei 9.656/98 e que os procedimentos cirúrgicos realizados ocorreram de forma eletiva, particular e em hospital de rede master. Aduz ainda a ré, que o caso dos autos não se trata de urgência e/ou emergência pois os laudos formulados pelos médicos assistentes dos autores não apontam urgência, não se justificando de forma alguma o pedido de reembolso, vez que os médicos cooperados e clínicas/hospitais credenciadas poderiam realizar o tratamento de que os autores necessitavam. Afirma que em momento algum recebeu qualquer solicitação prévia dos autores para que fosse autorizado o procedimento cirúrgico, e que os procedimentos realizados foram fora da rede credenciada da Unimed, ressaltando que o plano dos autores tem abrangência nacional, e que eles poderiam ter realizado os procedimentos cirúrgicos com qualquer profissional cooperado em qualquer hospital credenciado, e que os mesmos optaram em realizar fora da rede credenciada à Unimed e em Hospital de Alto Custo. Quanto ao pedido de reembolso do medicamento Temodal, diz que há ausência de cobertura contratual, nos termos da Cláusula X do contrato firmado entre as partes, e que quando do requerimento da autora, a mesma não se encontrava internada, bem como no caso de planos antigos não adaptados à Lei 9.656/98, somente terá cobertura caso haja previsão contratual expressa. Acerca da prótese do autor, diz que também não pode haver reembolso, tendo em vista a expressa exclusão contratual na referida cláusula contratual. No mérito aduz a inaplicabilidade da Lei n. 9.656/98 ao caso concreto, da inexistência de violação ao Código de Defesa do Consumidor, da ausência de descumprimento das obrigações pela ré e do total descabimento do pedido de reembolso. Requer assim, dentre outros pedidos, o julgamento improcedente do pedido.

Impugnação à contestação às fls. 336/357, na qual os autores alegam, dentre outros, que a ação fora proposta em face da empresa Unimed Nova Friburgo Sociedade Cooperativa Médica Ltda, vez que esta é a atual gestora de seu plano de saúde. Asseveram,

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por VANIA DE PAULA ARANTES, liberado nos autos em 17/12/2021 às 09:30 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0826839-89.2018.8.12.0001 e código UmgcPw7j.

contudo, que a contestação acostada ao feito fora subscrita pela empresa Unimed Teresópolis, a qual não participa da ação. Por conta disso, requer seja decretada a revelia da requerida.

As partes foram intimadas para indicarem as provas que pretendem produzir (fl. 359), a ré requer a produção de prova oral, consistente na oitiva de testemunhas e ainda prova documental (fls. 360/361), a autora requer a inversão do ônus da prova (fls. 362/366).

Manifestação da ré às fls. 378/380 onde se manifesta sobre a preliminar de revelia arguida pela autora em impugnação à contestação, alegando que os autores eram beneficiários da Unimed Teresópolis à época dos fatos, e em que pese a alienação da carteira de beneficiários da Unimed Teresópolis à Unimed Nova Friburgo, apenas as obrigações assistenciais decorrentes da referida carteira e relativa aos eventos ocorridos a partir de 01/04/2018 serão suportados pela Unimed Nova Friburgo, considerando que os fatos narrados na exordial ocorreram antes da alienação da carteira de beneficiários, a Unimed Teresópolis é a única parte legítima para figurar no polo passivo da demanda.

O feito foi saneado às f. 399/403, ocasião em que se afastou a tese de revelia e aceitou a contestação juntada ao feito. Foram fixados os pontos controvertidos e deferida a produção de prova documental. Designou-se audiência de instrução e julgamento, para oitiva de testemunhas arroladas pela ré.

Os autores opuseram embargos de declaração às f. 412/415, pugnando por esclarecimentos na decisão saneadora, no que diz respeito aos pontos controvertidos.

À f. 420, comunicou-se o óbito dos requerentes e, na mesma ocasião, pugnou-se pela sucessão processual pelos respectivos espólios, representados por Roberta Lauria Lima. Juntada de certidão de óbito às f. 421/422 e de escritura pública de inventário às f. 423/467.

Às f. 473/474, acolheu-se os aclaratórios opostos pelos autores, para fins de readequação dos pontos controvertidos.

Os autores opuseram embargos de declaração às f. 479/480, alegando erro material na decisão de f. 473/474, porquanto menciona páginas diversas, que não possuem relação com os embargos de declaração de f. 412/415 e com a decisão de f. 399/403. Alem disso, afirma que a decisão consta que estão sendo acolhidos aclaratórios opostos pelo réu, o que não é verdade, pois o recurso foi oposto pelos autores. Por fim, reitera o pedido de readequação do pólo ativo.

A ré, às f. 485/486, desistiu da prova oral.

Termo de assentada à f. 488, no qual constou que as partes não se compuseram. Homologou-se o pedido de desistência da prova oral formulado pelo réu. Determinou-se a remessa do feito para prolação de sentença.

Os autores, às f. 489/493, pugnaram pela análise dos aclaratórios de f. 479/480 e pela regularização do pólo ativo da ação. Alem disso, teceram comentários quanto à ação e as provas produzidas, esclarecendo pontos controversos e pedindo a procedência do Pedido.

Às f. 494/499, foram acolhidos os aclaratórios de f, 479/480, corrigindo-se as páginas mencionadas na decisão atacada. Ao final, determinou-se a regularização do pólo ativo da ação, com a inclusão das herdeiras dos autores falecidos.

Às f. 505/508, as herdeiras dos autores falecidos (Roberta Lauria Lima e Daniela Lauria Lima) se apresentaram no feito e pediram a sucessão processual junto ao pólo ativo da ação.

Relatados. Decido.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por VANIA DE PAULA ARANTES, liberado nos autos em 17/12/2021 às 09:30 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0826839-89.2018.8.12.0001 e código UmgcPw7j.

Poder Judiciário de Mato Grosso do Sul
Comarca de Campo Grande
4ª Vara Cível Residual

Trata-se de *Ação de Indenização por Danos Materiais* que **Ronaldo Lanes Lima e Cleida Maria Lauria Lima** movem em face de **Unimed Nova Friburgo Sociedade Cooperativa Médica Ltda**, todos devidamente qualificados nos autos.

1 – Da Regularização do Pólo Ativo

Diante do óbito de ambos os autores durante o trâmite processual, conforme certidões de óbito de f. 421/422 e, ainda, autorizo, nos termos do art. 110 do CPC, a sucessão processual pelas suas herdeiras (filhas: Roberta Lauria Lima e Daniela Lauria Lima), a quais passam a compor o pólo ativo da ação.

Às anotações junto ao SAJ.

2 – Do Julgamento da Ação

Considerando-se que a parte autora não formulou pedido de provas (f. 362/366) e que o réu desistiu da prova oral anteriormente pleiteada (f. 485/486), o que inclusive foi homolagado pelo Juízo (f. 488), e ainda, verificando-se que não há mais provas a serem produzidas, tenho que o feito admite o julgamento no estado em que se encontra, nos termos do art. 355, I, do CPC.

2.1 – Das Normas Aplicadas ao Caso

De início, destaca-se o contrato firmado pelas partes fora firmado em 11/10/1996 (fl. 247/248), de modo que, ao presente caso, não incidem as regras previstas na Lei n. 9.656/98, vez que a mesma fora publicada em data posterior à entabulação do negócio jurídico.

Tal conclusão, aliás, decorre do entendimento adotado pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) 1931, que questionou a Lei 9.656/1998 (Lei dos Planos de Saúde), o qual, por unanimidade dos votos, considerou válida a maioria dos dispositivos, mas entendeu que os contratos celebrados antes da vigência da norma não podem ser atingidos pela regulamentação dos planos de saúde.

Anote-se, contudo, que embora a Lei n. 9.656/98 não retroaja aos contratos firmados antes de sua vigência, não há óbice para que o contrato seja revisto à luz dos comandos da legislação consumerista, mesmo que firmados antes da vigência do CDC, vez que se trata de obrigação de trato sucessivo, renovando-se ao longo do tempo, portanto, submetendo-se às normas supervenientes, especialmente às de ordem pública, como o Código de Defesa do Consumidor, o que não significa ofensa ao ato jurídico perfeito.

Aliás, é o que entende o E. TJMS:

> *"EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – PLANO DE SAÚDE – OMISSÃO E CONTRADIÇÃO INEXISTENTES – CONTRATO FIRMADO ANTES DA VIGÊNCIA DA LEI 9656/98 – IRRETROATIVIDADE MANTIDA – PACIENTE COM DOENÇA RENAL GRAVE – SUBMETIDO A TRANSPLANTE DE RIM SEM ÊXITO, NECESSITANDO DE HEMODIÁLISE E DIÁLISE PERITONEAL – RISCO DE VIDA - PREVISÃO DO*

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por VANIA DE PAULA ARANTES, liberado nos autos em 17/12/2021 às 09:30 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0826839-89.2018.8.12.0001 e código UmgcPw7j.

*TRATAMENTO DA DOENÇA – CLÁUSULA QUE EXCLUI PROCEDIMENTOS NECESSÁRIOS AO TRATAMENTO DO PACIENTE – ABUSIVIDADE CONSTATADA - VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA BOA-FÉ, FUNÇÃO SOCIAL DO CONTRATO E DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA – OBSERVÂNCIA DOS DISPOSITIVOS LEGAIS VIGENTES E DA JURISPRUDÊNCIA DAS CORTES SUPERIORES – VÍCIOS NÃO CONSTATADOS – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1- **Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, embora a Lei n. 9.656/98 não retroaja aos contratos firmados antes de sua vigência, é possível aferir a abusividade de cláusulas à luz dos comandos da legislação consumerista, mesmo que firmados antes da vigência do CDC. Isso se dá em razão de que o contrato de plano de saúde é obrigação de trato sucessivo, renovando-se ao longo do tempo e, portanto, submetendo-se às normas supervenientes, especialmente às de ordem pública, como o Código de Defesa do Consumidor.** 2- Tratando-se de contrato de adesão onde há previsão do tratamento da doença que acomete o paciente, é abusiva a cláusula que exclui os procedimentos necessários a tal fim, porque viola os princípios da boa-fé, da função social do contrato e da dignidade da pessoa humana. 3- É apta a causar dano moral, de natureza grave, a negativa, pelo plano de saúde, de cobertura a procedimento essencial à preservação da vida do paciente. A fixação do valor da indenização deve considerar as particularidades do caso concreto, em especial a gravidade do dano e sua finalidade pedagógica. 4- Não constatados os vícios que ensejam o acolhimento dos aclaratórios, sua rejeição é medida que se impõe.(**TJMS**. Embargos de Declaração Cível n. 0808145-14.2014.8.12.0001, Campo Grande, 3ª Câmara Cível, Relator (a): Des. Fernando Mauro Moreira Marinho, j: 12/03/2019, p: 13/03/2019)".*

E é partir desta premissa que o caso em apreço será analisado.

2.2 – Do Reembolso de Valores

2.2.1 – Das Cirurgias Feitas em Hospital Não Credenciado (Honorários Médicos, Internação e Exames)

No caso vertente, observa-se que os autores Ronaldo e Cleida (que faleceram durante o feito) são beneficiários do plano privado de assistência à saúde administrada pela requerida.

No que tange à autora Cleida, vê-se que a mesma, em meados de fevereiro/2018, iniciou sintomas de cefaleia e procurou o médico credenciado da ré, Dr. Fernando Augusto T. Vasconcellos Dias, o qual lhe solicitou exames, conforme documentos de f. 39/42. Observa-se que, na sequencia, a autora, por indicação de seu médico e para a investigação de sua patologia, procurou tratamento médico em São Paulo/SP, junto ao

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por VANIA DE PAULA ARANTES, liberado nos autos em 17/12/2021 às 09:30 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0826839-89.2018.8.12.0001 e código UmgcPw7j.

Hospital Sírio Libanês (não credenciado à requerida), ocasião em foi diagnosticada com tumor cerebral à esquerda e submetida a cirurgia naquele hospital, conforme laudo de f. 46/48, fato confessado na inicial.

Já no que se refere ao autor Ronaldo, vê-se que o mesmo foi diagnosticado com "esponcilite anquilosante", desde que tinha 18 anos, sendo que no ano de 2007 foi submetido a cirurgia de prótese do quadril direito. Alega que, no ano de 2014, apresentou outras dores e precisou fazer novo procedimento cirúrgico, o qua realizou junto ao Hospital Sírio Libanês em São Paulo/SP, não credenciado à ré, fato reconhecido na inicial e comprovado através do laudo médico de f. 134.

Assim, ambos os autores pedem o reembolso das despesas com o referido tratamento médico junto ao Hospital Sírio Libanês (não credenciado).

O pedido, contudo, merece **improcedência**, ao menos neste particular.

Nessa senda, é sabido que o custeio de tratamento com médico não credenciado é autorizado somente em hipóteses especificas (tratamento emergencial/urgente ou falta de profissional habilitado pela ré). **Portanto, é certo que, não havendo urgência ou emergência, o beneficiário de plano de saúde que opta por realizar atendimento médico em estabelecimento não contratado, credenciado ou referenciado pela operadora, tem o respectivo ônus financeiro de custear as despesas decorrentes, não cabendo reembolso pelo plano de saúde.**

Esse é o entendimento do E. TJMG:

> *"APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - PLANO PRIVADO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE - INDEFERIMENTO DE PROVA - DILIGÊNCIA DISPENSÁVEL À SOLUÇÃO DA CONTROVÉRSIA - CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO - PROCEDIMENTO MÉDICO REALIZADO EM ESTABELECIMENTO NÃO CREDENCIADO - OPÇÃO DA BENEFICIÁRIA - REEMBOLSO INTEGRAL DAS DESPESAS - IMPOSSIBILIDADE - RECUSA FUNDADA EM CLÁUSULA CONTRATUAL EXPRESSA - DANOS MORAIS AFASTADOS. 1. (...) 2. **O beneficiário de plano de saúde que, não sendo caso de urgência ou emergência, opta por realizar atendimento médico em estabelecimento não contratado, credenciado ou referenciado pela operadora, tem o respectivo ônus financeiro de custear as despesas decorrentes, restando limitada a obrigação de reembolso da operadora aos preços praticados pelos serviços médicos e hospitalares junto aos prestadores credenciados. (...)**" (TJMG - Apelação Cível 1.0000.19.120031-0/002, Relator(a): Des.(a) Fausto Bawden de Castro Silva (JD Convocado) , 9ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 18/08/2020, publicação da súmula em 24/08/2020) destaquei*

Na hipótese, conforme conjunto probatório, não ficou comprovada urgência ou emergência para o tratamento dos autores em hospital não credenciado do plano de saúde da Unimed, tanto que inexistentes estas afirmações junto aos laudos de f. 46/48 e 134, deixando evidente que o tratamento se deu naquele Hospital (Sírio Libanês) por livre e espontânea liberalidade dos requerentes, e que o mesmo tinha caráter **eletivo**.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por VANIA DE PAULA ARANTES, liberado nos autos em 17/12/2021 às 09:30 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0826839-89.2018.8.12.0001 e código UmgcPw7j.

É o que se extrai do laudo de f. 134, o qual deixa claro que o autor Ronaldo era portador de "esponcilite anquilosante" desde o ano de 1967 (quando tinha 18 anos – f. 25), com dores detectadas desde o ano de 2013, sendo a cirurgia realizada apenas no ano de 2014, ou seja, com mais de anos após o diagnostico, o que é suficiente para evidenciar que a situação, apesar de gravosa, não era de urgência e/ou emergência, mas sim **eletiva.**

A pedido do interessado, Sr. RONALDO LANES LIMA, na qualidade de seu médico assistente, atesto para os devidos fins que o mesmo tem o diagnóstico de esponcilite anquilosante desde os 18 anos de idade. Em 2007 foi submetido a cirurgia de protese do quadril direito com bom resultado.
Em janeiro de 2013 sofreu queda da própria altura sendo diagnosticada fratura da coluna lombar mas com evolução favorável. Em dezembro de 2013 voltou apresentar dor toracolombar, sem irradiação , que piorava à movimentação , sem comprometimento neurológico.
Exames de imagem mostravam fratura do corpo de L2.
Persistindo o quadro álgico da coluna vertebral e tendo melhora das outras dores articulares foi submetido a artrodese de T12 a L5 no dia 27 de maio de 2014, no Hospital Sírio Libanes na cidade de São Paulo, sem apresentar uma melhora significativa da dor.
Exames de imagem de junho de 2017 (radiografias e tomografia computadorizada) mostram fratura da coluna vertebral alinhada e sem soltura do material de sintese.
O paciente continua com quadro de dor toraco lombar.

São Paulo, 23 de agosto de 2018

Dr. Mario Augusto Taricco
CRM - 22.357

Dr. Mario Augusto Taricco
CRM - 22.357

O mesmo ocorre com a autora Cleida, já que em que pese a autora tenha sido diagnosticada com doença grave (câncer) e tenha inclusive sido submetida a tratamento cirúrgico para remoção do tumor (f. 46/48), é de se notar que o tratamento, apesar de necessário, era **seletivo**, sem caracteristiscas de urgência e emergência, especialmente porque a procura por um tratamento se deu ainda no Estado de Mato Grosso do Sul (f. 41) e, na ocasião, **a autora apesar de indicação para a procura de neurocirurgião (conforme informado na inicial), sequer procurou este profissional nesta Capital ou Estado, tendo, por iniciativa da sua família, iniciado o tratamento em São Paulo, em hospital não credenciado ao plano de saúde que havia contratado.**

Confira o histórico constante do laudo de f. 47/48:

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por VANIA DE PAULA ARANTES, liberado nos autos em 17/12/2021 às 09:30 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0826839-89.2018.8.12.0001 e código UmgcPw7j.

Poder Judiciário de Mato Grosso do Sul
Comarca de Campo Grande
4ª Vara Cível Residual

São Paulo, 13 de março de 2018.

Referência: Cleida Maria Lauria Lima

Diagnóstico: glioblastoma multiforme (CID C71)

Declaro, a pedido do interessado, que a paciente em referência é portadora do diagnóstico supra-citado e passou por consulta com esta equipe pela primeira vez em 12/03/2018. Àquela ocasião, apresentada o seguinte histórico:

Fevereiro 2018: episódio de turvação visual, associado a vertigem e diminuição de equilíbrio. A duração desta queixa foi 20 a 30 minutos, com resolução espontânea

15 dias após, apresentou novo episódio semelhante, associado a cefaleia. Foi ao seu médico que solicitou exames.

Março 2018: veio para São Paulo e se consultou com neurocirurgião (Dr. Felix Hendrik Pahl) que procedeu com investigação, pedindo ressonância magnética de crânio.

Março 2018: ressonância de crânio mostrando lesão expansiva / infiltrativa temporal e cápsula nuclear a esquerda, com diâmetros transversos máximos de 6,1 x 5,3 x 3,6 cm. Apresenta captação periférica pelo meio de contraste, onde há restrição à movimentação das moléculas de água e produtos de degradação da hemoglobina, com porções centrais liquefeitas / necróticas. Edema / infiltração do parênquima circunjacente de pequena monta e delineando cápsulas à esquerda.

06/03/2018 - neurocirurgia. O exame anátomo-patológico revelou um GLIOBLASTOMA MULTIFORME GRAU IV (OMS), ausência de imunoexpressão da proteína p53, ATRX positivo (expressão mantida) e ausência de expressão de IDH1.

Diante deste quadro, nossa indicação foi a realização de radioterapia associada com quimioterapia baseada em temozolamida. O tratamento quimioterápico será conduzido sob responsabilidade de equipe de oncologia clínica desta instituição (Dra. Caroline Chaul).

Concernente à radioterapia, serão 30 frações (sessões) realizadas em 6 semanas, perfazendo dose total de 60Gy (protocolo mundialmente seguido). Favorecemos técnica de IMRT para minimizar irradiação de estruturas sadias adjacentes, como a via óptica, a hipófise, os olhos, dentre outras.

Sem mais,

Samir Abdallah Hanna
Médico Radio–oncologista
CRM 91337 – SP

Inclusive, o E. TJMS entendeu de forma semelhante em caso análogo:

> *APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES C/C DANO MORAL – AUTORA CONVENIADA DE PLANO DE SAÚDE - PORTADORA DE CÂNCER – TRATAMENTO EM HOSPITAL NÃO CONVENIADO – NÃO DEMONSTRADA URGÊNCIA OU EMERGÊNCIA – PROVA PERICIAL ATESTANDO TRATAMENTO ELETIVO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.* ***I - É certo que, não havendo urgência ou emergência, o beneficiário de plano de saúde que opta por realizar atendimento médico em estabelecimento não contratado, credenciado ou referenciado pela operadora, tem o respectivo ônus financeiro de custear as despesas decorrentes, não cabendo reembolso pelo plano de saúde.*** *II - Na hipótese, conforme conjunto probatório, não ficou comprovada urgência ou emergência para o tratamento da Autora em hospital não credenciado do plano de saúde da Unimed.* ***III - Não se descura que a Autora teve doença grave e necessitou que quimioterapia e tratamento cirúrgico para remoção de tumor, porém é de se notar que a conclusão do laudo pericial é de que referido procedimento foi eletivo.*** *IV - Segundo relatos da própria autora ao perito judicial, verifica-se que descobriu o câncer com sua ginecologista de Campo Grande, porém sequer procurou oncologista nesta cidade, tendo, por iniciativa da sua família, iniciado o tratamento em São Paulo, em hospital não credenciado ao plano de saúde que havia contratado. V -*

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por VANIA DE PAULA ARANTES, liberado nos autos em 17/12/2021 às 09:30 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0826839-89.2018.8.12.0001 e código UmgcPw7j.

> *Portanto, a Autora tinha opção se fazer o tratamento em hospital conveniado de seu plano de saúde, como ocorreu após a cirurgia, pois atualmente faz acompanhamento com oncologista clínico nesta cidade, mas assim não procedeu. VI - Logo, como a autora não se desincumbiu do ônus de provar os fatos constitutivos do direito pleiteado, a recusa de restituição de valores pela parte requerida é legítima e, por isso, não há que se falar em dano de ordem moral. VII - À luz dessas considerações, deve ser mantida a sentença de improcedência dos pedidos de restituição de valores e indenização por danos morais. VIII – Recurso conhecido e desprovido. (**TJMS**. Apelação Cível n. 0809561-41.2019.8.12.0001, Campo Grande, 4ª Câmara Cível, Relator (a): Juiz Lúcio R. da Silveira, j: 06/05/2021, p: 12/05/2021).*

Ou seja, tanto um autor como o outro tinham opção de fazer o tratamento em hospital conveniado de seu plano de saúde, mas assim não procedeu, preferindo fazer uso de hospital de alto custo, sem convênio com a ré, assumindo pois o ônus de arcar com os respectivos gastos.

Ademais, ainda que as partes mantenham relação de consumo, com a possibilidade de revisão das claúsulas abusivas, fato é que o objeto central do contrato deve ser respeitado, de modo que, ao contratar plano de saúde, a parte contratante tem ciência de que seus tratamentos médicos, se necessários, serão sempre feitos por profissionais cadastrados junto aquele plano de saúde, de modo que adotar entendimento diverso, acarreta em ofensa ao próprio negócio jurídico.

É o que diz o E. TJSP:

> *APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. PACIENTE DIAGNOSTICADO COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. PRETENSÃO DE REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO PELO MÉTODO ABA EM REDE NÃO CONVENIADA. IMPOSSIBILIDADE. DEMONSTRAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE CLÍNICA NA REDE CREDENCIADA DEVIDAMENTE HABILITADA PARA O TRATAMENTO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. A Operadora do Plano de Saúde não está obrigada ao custeio de tratamento fora de sua rede conveniada quando possui profissionais cooperados capacitados. (TJSP; Apelação Cível 1000407-05.2019.8.26.0040; Relator (a): Maria do Carmo Honorio; Órgão Julgador: 3ª Câmara de Direito Privado; Foro de Américo Brasiliense - 2ª Vara; Data do Julgamento: 05/03/2021; Data de Registro: 05/03/2021).*

Também é importante destacar que, alem dos procedimentos serem eletivos no caso em apreço, é fato que a ré possuía diversos profissionais capacitados para atender as demandas médicas dos requerentes, conforme rol indicado à f. 284/329 e não impugnado pelos requerentes, não sendo portanto obrigada a custear tratamento junto a profissional não credenciado ao seu quadro de fornecedores, sob pena de ofensa ao que restou

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por VANIA DE PAULA ARANTES, liberado nos autos em 17/12/2021 às 09:30 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0826839-89.2018.8.12.0001 e código UmgcPw7j.

pactuado entre as partes.

Assim, não restam dúvidas de que a parte autora não comprovou nos autos nenhuma das hipóteses que autorizam o custeio de tratamento por hospital não credenciado, de modo que o pedido reembolso a este título deve ser julgado **improcedente.**

2.2.2 – Medicamento Temodal (Temozolomida) - Quimioterapia

Em sua inicial, a autora pede ainda o reembolso dos valores gastos com o medicamento "Temodal", prescrito pelo médico em razão do seu diagnóstico de câncer.

O pedido, neste ponto, merece **procedência**. Explica-se.

Os contratos envolvendo relação de consumo, como na espécie, têm de ser interpretados à luz do novo paradigma protetivo e de princípios tais como: "vulnerabilidade do consumidor" (art. 4ª, I, do CDC); "da interpretação das cláusulas contratuais de maneira mais favorável ao consumidor" (art. 47, do CDC), entre outros, competindo ao julgador, no caso concreto, ponderar os fatos apresentados, de sorte a tomar a decisão que mais se aproxima do justo.

Demais disso, em caso de conflito entre o interesse do usuário e o interesse do fornecedor, o contrato deverá ser interpretado favoravelmente ao consumidor (pró-consumidor) segundo a disposição constante do artigo 47.

Ademais, sabe-se que na atualidade, já não é aceitável alegar-se o pacta sunt servanda para legitimar cláusulas contratuais abusivas, porquanto a relação jurídica que lhes deu origem é regulada pelo Código de Proteção e de Defesa do Consumidor e, frente a tais disposições, as chamadas cláusulas abusivas são nulas de pleno direito, cujo reconhecimento poderá ocorrer a qualquer tempo e em qualquer grau de jurisdição; muito mais se inseridas nos chamados contratos de adesão.

Neste sentido, de fato, o documento médico de f. 53, datado de 27 de abril de 2018 e assinado pela médica Dra. Caroline Chaul de Lima Barbosa (oncologista), comprova que a autora Cleida foi diagnosticada com Glioblastoma multiforme (câncer cerebral), com prescrição de radioterapia e quimioterapia através do medicamente "Temozolamida":

659400

São Paulo, sexta-feira, 27 de abril de 2018
Para: Cleida Maria Lauria Lima
SAME: 659400
Endereço: Júlio Barone - Apto 201 - CEP: 79010090 - Monte Castelo - Campo Grande - MS

Orientações

A paciente Cleida Maria Lauria Lima, 65 anos, iniciou em Fevereiro de 2018 episódios d turvação visual, associados a vertigem e diminuição de equilíbrio. Na época, evoluiu com início também de cefaleia progressiva.

Em Março/18, procurou AM e realizou RNM de crânio, que evidenciou lesão temporal E sugestiva de glioma de alto grau, com edema perilesional importante. Em 06/03/18, submetida à ressecção Macrototal da lesão. O exame anatomopatológico foi consistente com Glioblastoma Multiforme (CID 10 C71.9).

Avaliada pela oncologia clínica durante internação. Indicado tratamento adjuvante com Radioterapia e quimioterapia, aos moldes do protocolo Stupp. O tratamento de radioterapi com quimioterapia concomitante (Temozolamida 75mg/m2 diariamente, 42 dias) foi iniciad em 26/03/18. A quimioterapia adjuvante isolada (Temozolamida 200mg/m2, D1-5, a cada 28 dias) deverá ser iniciada em 04/06/18, com duração de 12 ciclos (aproximadamente, 1 ano de duração do tratamento).

Encontro-me a disposição para esclarecimentos.

Atenciosamente,

Dra. Caroline Chaul de Lima Barbosa
CRM: 131520

Caroline Chaul Barbosa
Oncologia Clínica
CRM 131520

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por VANIA DE PAULA ARANTES, liberado nos autos em 17/12/2021 às 09:30 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0826839-89.2018.8.12.0001 e código UmgcPw7j.

A ré, contudo, negou o custeio do medicamento, sob o fundamento de que o medicamento é de uso domiciliar e não conta com cobertura contratual, conforme negativa expressa de f. 279/281 e confissão em sede de contestação.

Ocorre que, ao contrário do que defende a ré, qualquer restrição a procedimento considerado inafastável para o tratamento de moléstia coberta pelo plano de saúde é de ser considerada nula de pleno direito, porquanto, suprime um direito do contratante, sendo defeso ao plano de saúde questionar o tratamento prescrito pelo médico, sob pena de negar a finalidade precípua do contrato, o que fere a razoabilidade.

Assim, se a doença encontra cobertura no ajuste firmado (como é o caso, já que a autora era portadora de câncer cerebral e o tratamento da referida moléstia está acobertada no plano de saúde contratado – conforme cláusula IX do contrato – f. 253/254 - "oncologia"), como ocorre neste caso, o tipo de tratamento a ser feito é aquele que for indicado pelo profissional da saúde eleito pela paciente.

Ademais, em recente consulta ao sítio da ANS[1], nota-se que referida Agência Sumplementar **incluiu na lista obrigatória dos planos de saúde o medicamento Temozolamida, para fins de "TERAPIA ANTINEOPLÁSICA ORAL PARA TRATAMENTO DO CÂNCER**, vejamos:

64. TERAPIA ANTINEOPLÁSICA ORAL PARA TRATAMENTO DO CÂNCER

SUBSTÂNCIA	LOCALIZAÇÃO	INDICAÇÃO

[1] disponível em: http://www.ans.gov.br/images/stories/parecer_tecnico/uploads/parecer_tecnico/_PARECER_27-2018_MEDICAMENTOS%20ANTINEOPLSICOS%20ORAIS_VERSO%20FINAL_27122017.Pdf , acesso em 01/12/2021

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por VANIA DE PAULA ARANTES, liberado nos autos em 17/12/2021 às 09:30 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0826839-89.2018.8.12.0001 e código UmgcPw7j.

Temozolamida	SNC - Sistema Nervoso	Glioblastoma multiforme em adjuvância ou doença

Publicado em 02/01/2018

ANS Agência Nacional de Saúde Suplementar

SUBSTÂNCIA	LOCALIZAÇÃO	INDICAÇÃO
	Central	recidivada
	SNC - Sistema Nervoso Central	Glioma maligno, tal como glioblastoma multiforme ou astrocitoma anaplásico, recidivante ou progressivo após terapia padrão

Assim, não restam dúvidas de que incumbe a ré arcar com os custos de tal medicamento. Neste sentido, diz o E. TJMS:

> *APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PLANO DE SAÚDE – TRATAMENTO MÉDICO PARA CÂNCER DE PULMÃO – MEDICAMENTO ALECENSA – ABUSIVIDADE DA CLÁUSULA DE PLANO DE SAÚDE QUE EXCLUI MEDICAMENTE NECESSÁRIO A TRATAMENTO COBERTO, AINDA QUE EM ÂMBITO DOMICILIAR – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. Tem-se entendido ser abusiva cláusula contratual que exclui o fornecimento de medicamento, ainda que de uso domiciliar, quando o tratamento é essencial para garantir a saúde e, em algumas vezes, a vida do segurado, considerando que podem-se estabelecer as doenças que terão cobertura, mas não o tipo de tratamento utilizado para a cura de cada uma.*
> *(**TJMS**. Apelação Cível n. 0834487-86.2019.8.12.0001, Campo Grande, 4ª Câmara Cível, Relator (a): Juiz Luiz Antônio Cavassa de Almeida, j: 19/08/2021, p: 24/08/2021).*

A partir disso, verificada a responsabilidade de custeio do medicamento "temodal" pela ré, e demonstrado o seu prejuízo material nos termos da nota fiscal de f. 66/68 (R$ 6.388,00; R$ 6.388,00; e R$ 13.826,00), julgo **procedente** o pedido autoral, neste particular, e condeno a ré ao **reembolso dos valores gastos pela autora com a compra do referido medicamento, no valor total de R$ 26.602,00 (vinte e seis mil e seiscentos e dois reais)**, com correção monetária pelo IGPM/FGV a partir de cada reembolso e de juros de mora de 1% ao mês, a contar da data da negativa (22/03/2018 – f. 279/281), já que fora ali que se configurou a mora da ré.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por VANIA DE PAULA ARANTES, liberado nos autos em 17/12/2021 às 09:30 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0826839-89.2018.8.12.0001 e código UmgcPw7j.

2.2.3 – Da Prótese/Órtese

A parte autora, em sua inicial, ainda pede a condenação da ré ao reembolso dos valores pagos pelo autor, referente à órtese/prótese utilizada em procedimento cirúrgico atinente ao requerente Ronaldo.

Como já dito no item 2.2.1 desta sentença, não é cabível à restituição de valores afetos à cirurgia feita no autor Ronaldo (*isto é, honorários médicos, exames e diárias de internação*), pois decorre de procedimento eletivo, feito em rede não credenciada à requerida.

Tal conclusão, no entanto, não afasta o direito do autor em ver restituído os valores pagos a título de *órtese/prótese*, vez que tais equipamentos são cobertos pelo plano de saúde contratado em qualquer caso, conforme cláusula IX (f. 253/254), impondo-se sua restituição, ainda que o procedimento tenha sido feito em hospital não credenciado, já que o preço anotado é aquele indicado pelo fornecedor, independente do nosocômio utilizado.

É o que diz o E. TJSP:

> PLANO DE SAÚDE. PRÓTESES. REDE NÃO CREDENCIADA. REEMBOLSO. Sentença de improcedência. Irresignação da autora. **1. Prótese. Reembolso devido. Necessidade da prótese para o procedimento cirúrgico. Cobertura obrigatória. Entendimento do Enunciado 22 da 3ª Câmara de Direito Privado e da Súmula 102 do TJ-SP. Irrelevância de a cirurgia ter sido realizada fora da rede credenciada. Prótese que seria de cobertura obrigatória em qualquer caso. Reembolso pelo valor informado pelo fornecedor do local da cirurgia realizada.** Não comprovação, pela ré (art. 373, II, CPC), de que o valor na rede credenciada seria inferior. (...) (TJSP; Apelação Cível 1002998-12.2015.8.26.0320; Relator (a): Carlos Alberto de Salles; Órgão Julgador: 3ª Câmara de Direito Privado; Foro de Limeira - 4ª Vara Cível; Data do Julgamento: 25/04/2017; Data de Registro: 26/04/2017)

Partindo dessa premissa, e em se tratando de órteses/próteses, é sabido que o plano de saúde pode cobrar pelo seu fornecimento quando tais objetos não estiverem associados ao ato cirúrgico em si, sendo vedada a cobrança de qualquer equipamento essencial ao tratamento médico, restando abusiva qualquer cláusula que estabeleça o contrário, já que contraria o proprio fim do contrato.

É o que diz o E. STJ:

> *"AGRAVO REGIMENTAL. PLANO DE SAÚDE. PROIBIÇÃO DO FORNECIMENTO DE PRÓTESE PARA CIRURGIA DE JOELHO. FUNDAMENTO INATACADO. SÚMULA STF/283. CLÁUSULA ABUSIVA. CARACTERIZAÇÃO. 1.- Analisando o contrato firmado entre as partes, concluiu o Tribunal de origem pela abusividade da cláusula que excluía de cobertura o uso de prótese, considerada essencial ao procedimento clínico*

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por VANIA DE PAULA ARANTES, liberado nos autos em 17/12/2021 às 09:30 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0826839-89.2018.8.12.0001 e código UmgcPw7j.

> *realizado, por violação do artigo 51, IV,do Código de Defesa do Consumidor. 2.- Esse fundamento, suficiente, por si só, para manter a conclusão do julgado, não foi impugnado nas razões do especial, atraindo, à hipótese, a aplicação da Súmula 283 do Supremo Tribunal Federal. 3.- Ademais, segundo o entendimento deste Tribunal, "se a colocação de próteses é necessária para o tratamento cirúrgico autorizado pela seguradora, é abusiva a cláusula que prevê sua exclusão da cobertura." (REsp 811.867/SP, Rel. Min. SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, DJe 22.4.10). 4.- Agravo Regimental improvido". (AgRg no AREsp 259.570/MG, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado em 11/12/2012, DJe 04/02/2013) "*

Neste sentido, verifica-se, na hipótese em apreço, que o autor (beneficiário do plano de saúde requerido) foi submetido a procedimento cirúrgico consubstanciado em "*Artrodese de T12 a L5*", conforme laudo médico de f. 134, sendo que as órteses/próteses utilizadas naquele procedimento totalizaram o montante de R$ 76.140,69 (setenta e seis mil e cento e quarenta reais e sessenta e nove centavos), conforme cobrança de f. 107.

Observa-se, ainda, que as próteses solicitadas pelo médico (f. 107) se enquadram na hipótese de próteses implantáveis, conforme informação contida no site da ANS - (https://www.ans.gov.br/images/stories/Plano_de_saude_e_Operadoras/Area_do_consumidor/materiais_implantaveis.Pdf) e **portanto inerentes ao proprio ato cirúrgico, de modo que, por configurar tratamento médico, devem sim ser pagas pelo plano de saúde.**

Ortese e Prótese

Seq.	Dt. Conta	Código	Descrição Material	Unid.	Qtde	Vl Unit.	Vl Total
			Centro Cirúrgico - Bloco C -				
1	27/05/2014	145913	Barra Lombar Sfs 450 mm - Ref 552145	Pç	1	3.872,41	3.872,41
2	27/05/2014	91699	Parafuso Pedicular Multi-Axial Lombar/Toraxico Sfs	Pç	1	4.276,59	4.276,59
3	27/05/2014	91700	Parafuso Pedicular Multi-Axial Lombar/Toraxico Sfs	Pç	7	4.276,59	29.936,13
4	27/05/2014	91701	Parafuso Pedicular Multi-Axial Lombar/Toráxico Sfs	Pç	4	4.276,59	17.106,36
5	27/05/2014	91702	Parafuso Pedicular Multi-Axial Lombar/Toraxico Sfs	Pç	1	4.276,59	4.276,59
6	27/05/2014	91710	Parafuso Pedicular Multi-Axial Lombar-Toráxico	Pç	1	4.276,59	4.276,59
7	27/05/2014	91904	Parafuso de Fixação Sfs - Ref 562001	Pç	14	885,43	12.396,02
			Total - Centro Cirúrgico - Bloco C -		29		76.140,69

Convém ressaltar também que, ainda que a ANS admitisse a cobrança destes equipamentos, é certo que a requerida não demonstrou que a cirurgia realizada no requerente (Artrodese) não estava inclusa na cobertura contratual, ônus probatório que lhe incumbia, nos termos do art. 373, II, do CPC, já que o contrato de fls. 247/266 não revela qualquer possibilidade de cobrança de materiais utilizados em procedimento cirúrgico, de modo que, caso fosse necessário o autor utilizar-se dos mesmos, como foi, caberia a ré proceder ao seu custeio, sendo evidente portanto o seu dever de reembolso.

Ademais, na hipótese, deve-se prevalecer a boa-fé das partes e o fim social do contrato, especialmente por se tratar de contrato de natureza consumerista, no qual, repisa-se, incidem as regras do CDC.

Assim, partindo dessa premissa, tem-se que os termos constantes de instrumento celebrado por adesão são sempre interpretados de forma mais benéfica ao

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por VANIA DE PAULA ARANTES, liberado nos autos em 17/12/2021 às 09:30 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0826839-89.2018.8.12.0001 e código UmgcPw7j.

aderente em detrimento do estipulante, tendo em vista que sua elaboração é feita de forma unilateral por este, onde são impostas as condições que irão reger a futura relação contratual, sem a participação do consumidor.

Tal circunstância determina que a interpretação das disposições contratuais nestes termos deve se dar de forma sistemática, teleológica e extensiva, para não causar desequilíbrio entre as partes contratantes. Nessa ordem de ideias, observa-se que existe cláusula que prevê a cobertura do tratamento médico do autor (inclusive procedimento cirúrgico – f. 253 – cláusula IX), revelando a dicotomia da relação juridica havida entre as partes e o desequilíbrio obrigacional ali existente, haja vista que de nada adianta a previsão para tratamento da doença do paciente (cirurgia) e de outra parte haja previsão expressa excluindo procedimento imprescindível àquele fim.

Não se está, por óbvio, negando vigência aos termos do contrato em discussão, tampouco desconsiderando as normas que regem as relações negociais, mas tão somente utilizando a hermenêutica em prol do equilíbrio entre os contratantes, observadas as peculiaridades no caso concreto, além dos princípios gerais aplicáveis ao caso, com prevalência ao da boa-fé, função social do contrato e dignidade da pessoa humana, já citados alhures.

Assim, pelos fundamentos já expostos, por tratar-se de material inerente ao ato cirúrgico, cujo custeio cabe ao plano de saúde réu, conforme contrato e cláusula de f. 253/254, sendo irrelevante o atendimento em rede credenciada ou não como já fundamentado, julgo **procedente** o pedido autoral, neste particular, e condeno a ré ao **reembolso dos valores gastos pela autora com as órteses e próteses descritas à f. 107, no valor total de R$ 76.140,69 (setenta e seis mil e cento e quarenta reais e sessenta e nove centavos)**, com correção monetária pelo IGPM/FGV a partir de cada reembolso e de juros de mora de 1% ao mês, a contar da data da citação, já que ausente negativa formal neste ponto.

Dispositivo

Nos termos do art. 487, I, do CPC, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS AUTORAIS, para o fim de:

- julgar improcedente o pedido referente ao reembolso das despesas médico-hospitalares relacionadas às cirurgias feito no Hospital Sírio Libanês/SP (não credenciado);

- julgar procedente o pedido e condenar a ré ao **reembolso dos valores gastos pela autora com a compra de medicamento "temodal", no valor total de R$ 26.602,00 (vinte e seis mil e seiscentos e dois reais)**, com correção monetária pelo IGPM/FGV a partir de cada reembolso e de juros de mora de 1% ao mês, a contar da data da negativa (22/03/2018 – f. 279/281), já que fora ali que se configurou a mora da ré;

- julgar procedente o pedido e condenar a ré ao **reembolso dos valores gastos pela autora com as órteses e próteses descritas à f. 107, no valor total de R$ 76.140,69 (setenta e seis mil e cento e quarenta reais e sessenta e nove centavos)**, com correção monetária pelo IGPM/FGV a partir de cada reembolso e de juros de mora de 1% ao mês, a contar da data da citação, já que ausente negativa formal neste ponto.

Ante a sucumbência, condeno ambas as partes (na proporção de 30% para autores e 70% para ré) ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios em favor dos patronos da parte contrária (na mesma proporção), os quais fixo em 15% do valor atualizado da condenação.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por VANIA DE PAULA ARANTES, liberado nos autos em 17/12/2021 às 09:30 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0826839-89.2018.8.12.0001 e código UmgcPw7j.

Poder Judiciário de Mato Grosso do Sul
Comarca de Campo Grande
4ª Vara Cível Residual

Certificado o trânsito em julgado, arquivem-se.

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

Campo Grande-MS, *data da assinatura digital*.

Vania de Paula Arantes
Juiz(a) de Direito

Assinado por Certificação Digital

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por VANIA DE PAULA ARANTES, liberado nos autos em 17/12/2021 às 09:30 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0826839-89.2018.8.12.0001 e código UmgcPw7j.